

*"¿Por qué decidimos acompañar  
nacimientos?"*

III CONGRESO DE PARTO HUMANIZADO

# Acompañamiento continuo durante el trabajo de parto

*Evidencia, experiencia humana y el rol de los equipos de salud en la prevención de la cesárea innecesaria*

III CONGRESO DE PARTO HUMANIZADO Y PREVENCIÓN DE LA CESÁREA INJUSTIFICADA

Emmanuel Andrades Rodríguez — Matrón, MGGS, Docente Universidad de Talca

2026



1 / 28



ACTO I · LA FRACTURA HISTÓRICA

# Frente a la cama de la paciente, ¿nosotros también acompañamos?

*ad companio — el que comparte el pan*

"Las exigencias clínicas pueden alejarnos del rol originario" · Pace et al., 2022



1 / 28





## LA HISTORIA DEL ACOMPAÑAMIENTO

*"Durante siglos, el parto fue un acontecimiento acompañado. La institucionalización fragmentó ese vínculo de forma sistemática."*

Hodnett et al., 2012 documentaron la erosión histórica de la presencia continua en las maternidades modernas.

Hodnett et al., 2012 · CD003766

## IMPACTO ACTUAL

# Fragmentada

"Fragmentada, inequitativa y frecuentemente nula"

Una revisión de alcance global evidenció que la mayoría de las mujeres en países de bajos y medianos ingresos dan a luz sin ningún tipo de acompañamiento continuo.

Bohren et al., 2023 · PLOS Global Public Health

*"Cuando pensamos en acompañamiento,  
solemos externalizarlo."*

Inequidad   Maltrato   Pérdida de Autonomía

59%

HAKIMI ET AL., 2025 — META-ANÁLISIS GLOBAL · 15 PAÍSES

*"Las mujeres describen vivencias de irrespeto y maltrato que incluyen negligencia, trato irrespetuoso y pérdida de autonomía decisional en el proceso del parto."*

Vedam et al., 2019 · Reproductive Health

¿Qué nos están intentando decir las mujeres?



1 / 28



*"Los modelos de continuidad de cuidados con matrona muestran que es posible integrar la presencia continua, el conocimiento clínico y el vínculo relacional dentro de sistemas de salud sostenibles."*

Sandall et al., 2024 · Cochrane CD004667 · Vedam et al., 2019 · Reproductive Health



## MUJERES INCLUIDAS EN LA EVIDENCIA COCHRANE

0

participantes en ensayos controlados aleatorizados sobre acompañamiento continuo durante el trabajo de parto · Bohren et al., 2017 · CD003766

**18.533**

Sandall et al., 2024

**16.414**

Jayasundara et al., 2024



1 / 28





# Efectos clínicos

BOHREN ET AL., 2017 · COCHRANE CD003766



# Certeza Moderada GRADE

Parto Vaginal Espontáneo

**RR 1.05**

IC95% 1.03–1.07

GRADE Moderada

Cesárea

**RR 0.91**

IC95% 0.84–0.99

GRADE Moderada

Parto Instrumental

**RR 0.89**

IC95% 0.83–0.96

GRADE Moderada

Mujeres incluidas

**18.533**

17 ECA incluidos

Modelo evaluado

Continuidad de cuidados con matrona  
(no acompañamiento puntual)

⚠ No extrapolar a modelos sin continuidad de cuidados — resultados específicos para midwifery-led continuity of care



1 / 28



REDUCCIÓN DE CESÁREA — BOHREN 2017

# RR 0.75

Limitación metodológica: heterogeneidad entre estudios ( $I^2=52\%$ ). Interpretar con cautela en contextos de alta medicalización.

**RR  $\approx$  0.61**

Rol de la Doula · Bohren 2017

**1.8% → 0.9%**

Cesárea NTSV



**Care Bundles**

Suess, 2022



1 / 28





# ¿Qué explica este hallazgo?

*La relación afectiva previa podría ser un componente relevante del beneficio observado.*

ANÁLISIS DE SUBGRUPOS · JAYASUNDARA ET AL., 2024

**RR 2.16**

Acompañante familiar

VS

**RR 1.22**

Acompañante formalmente entrenado

Jayasundara et al., 2024 · PLOS ONE, 19(7), e0298852

## INTERPRETACIÓN

- Relación afectiva previa
- Conocimiento de la mujer
- Apoyo emocional continuo
- Evidencia heterogénea



1 / 28





## DIMENSIONES DEL ACOMPAÑAMIENTO

# Objetivos del Acompañamiento

### CLÍNICOS

- | Reducción de cesárea
- | Reducción de parto instrumental
- | Menor uso de analgesia farmacológica

Bohren et al., 2017 · CD003766

### PSICOLÓGICOS

- | Autoeficacia materna
- | Reducción del miedo al parto
- | Experiencia positiva del nacimiento

Vedam et al., 2019 · Reproductive Health

### RELACIONALES

- | Vínculo triádico madre-RN-acompañante
- | Activación del acompañante significativo
- | Integración familiar al proceso

Simkin, 2017 · Birth, 44(4)

EVIDENCIA COMPARADA POR TIPO DE ACOMPAÑANTE

# ¿Quién Acompaña?



**Doula**

**RR 0.61**

Mayor reducción de cesárea en subgrupo de doulas vs. otras figuras acompañantes

Bohren et al., 2017 · CD003766



**Pareja / Familiar**

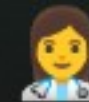
**RR 2.16** **RR 1.22**

No entrenado Entrenado

Jayasundara et al., 2024

Robson Gr. 1-2: OR 0.90 y 0.88

Ravit et al., 2026



**Personal Hospitalario**

Rol fundamental en la facilitación del vínculo.  
Barreras sistémicas reducen su efectividad.  
Sobrecarga clínica limita la presencia continua.

Bohren et al., 2023 · Pace et al., 2022



1 / 28



## MARCO NORMATIVO NACIONAL

# Regulación en Chile

**Ley 21.372 "Ley Mila"**

Reconoce el derecho de la mujer a ser acompañada por una persona de su elección durante el trabajo de parto, parto y puerperio inmediato.

**NT N° 222 MINSAL 2022**

Norma Técnica que reglamenta la implementación de la Ley Mila en establecimientos de salud públicos y privados de Chile.

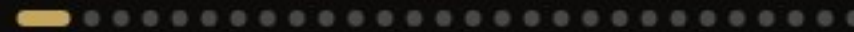
**Manual MINSAL 2008**

Manual de atención personalizada en el proceso reproductivo. Grado de evidencia A, nivel 1a — primera evidencia formal de recomendación en el país.

*¿Las barreras arquitectónicas como escudo para no cumplir la norma?*



1 / 28





MARCO REGULATORIO COMPARADO

# Regulación Internacional

| ORGANISMO | DOCUMENTO                 | RECOMENDACIÓN                                        | AÑO       |
|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| OMS       | Intrapartum Care          | Acompañamiento continuo recomendado · Grado fuerte   | 2018      |
| NICE      | NG235 Intrapartum Care    | Mujer tiene derecho a su acompañante de elección     | 2023/2025 |
| ACOG      | Committee Opinion No. 766 | Apoyo continuo como intervención basada en evidencia | 2019      |
| FIGO      | Respectful Care Statement | Acompañamiento como derecho fundamental              | 2025      |
| ICM       | Core Documents            | Integrado en estándares de competencia matronal      | 2024      |
| ICI       | 12 pasos ICI              | Paso 5: Apoyo continuo durante el trabajo de parto   | 2019      |



# *"¿Cuántas veces asumimos que el acompañante sabe acompañar?"*

Impotencia

Exclusión

Fallas de Comunicación

Tocofobia familiar: RR 1.73 vs. RR 1.34 (acompañante entrenado) · Jayasundara et al., 2024  
Hunter et al., 2026 · BMC Pregnancy and Childbirth · Longworth et al., 2015 · Midwifery



1 / 28





# ¿Cómo ayudamos al acompañante a acompañar?

## SIN PREPARACIÓN

- Ansiedad
- Miedo
- Impotencia
- Incertidumbre

## CON APOYO DEL EQUIPO

- Participación
- Confianza
- Contención
- Colaboración

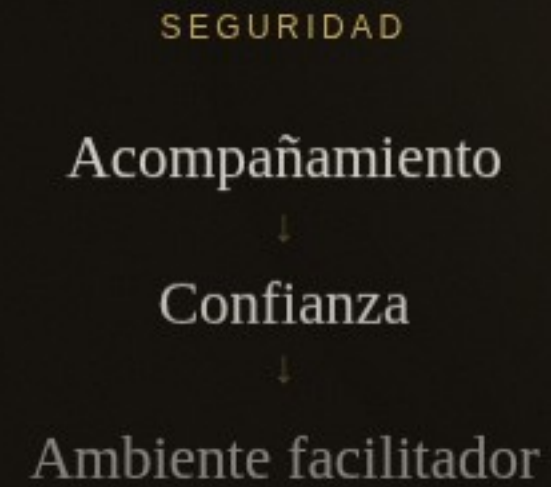
# La Tríada del Cuidado



*El acompañante acompaña a la mujer.*

*El equipo acompaña a ambos.*





## SISTEMAS Y ESTRUCTURAS

# Barreras Sistémicas

### Infraestructura

Salas de parto diseñadas sin contemplar la presencia de acompañantes. Falta de privacidad como argumento recurrente.

### Sobrecarga

Alta relación matrona-paciente. Turnos extendidos. Burnout profesional como barrera para el acompañamiento de calidad.

### Resistencia Cultural

Cultura hospitalaria que no reconoce el acompañamiento como intervención clínica. Desconfianza hacia el acompañante significativo.

## FORMACIÓN DE PROFESIONALES



ICM 2024 · MINSAL 2008 · Escuela de Obstetricia y Puericultura — Universidad de Talca



1 / 28



*El acompañamiento no reemplaza la excelencia  
técnica.  
La complementa.*



## AGENDA PENDIENTE

# Desafíos por Actor

### CLÍNICOS

- Integrar acompañamiento como intervención rutinaria
- Reducir barreras actitudinales
- Activar y preparar al acompañante
- Documentar la presencia del acompañante en ficha clínica

### DOCENTES

- Incorporar simulación clínica relacional en malla curricular
- Enseñar cómo facilitar vínculos, no solo cómo asistir partos
- Desarrollar competencias en comunicación triádica
- Evaluar actitudes, no solo procedimientos

### ESTUDIANTES

- Reflexionar sobre sesgos hacia el acompañante
- Practicar con familias simuladas
- Leer críticamente la evidencia disponible
- Reconocer la dimensión relacional del parto

### INSTITUCIONES

- Implementar Ley Mila sin excusas arquitectónicas
- Medir y auditar acompañamiento como indicador de calidad
- Diseñar espacios físicos que incluyan al acompañante
- Cuidar el bienestar de los equipos de salud

*"Si mañana pudieran cambiar  
una sola cosa..."*



## Referencias Bibliográficas

American College of Obstetricians and Gynecologists. (2019). Approaches to limit intervention during labor and birth. *Committee Opinion No. 766. Obstetrics & Gynecology*, 133(2), e164–e173.

Bohren, M. A., Hofmeyr, G. J., Sakala, C., Fukuzawa, R. K., & Cuthbert, A. (2017). Continuous support for women during childbirth. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2017(7), CD003766.

Hakimi, S., Allahqoli, L., Alizadeh, M., et al. (2025). Global prevalence and risk factors of obstetric violence: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Gynaecology & Obstetrics*, 169(3), 1012–1024. <https://doi.org/10.1002/ijgo.16145>

Jayasundara, D. M. C. S., et al. (2024). Impact of continuous labor companion — who is the best: A systematic review and meta-analysis. *PLOS ONE*, 19(7), e0298852.

Longworth, M. K., Furber, C., & Kirk, S. (2015). A grounded theory of men's experiences of birth partnering. *Midwifery*, 31(9), 844–857.

Ministerio de Salud de Chile. (2022). *Norma Técnica N° 222 — Ley N° 21.372*. MINSAL.

National Institute for Health and Care Excellence. (2023, actualizado 2025). *Intrapartum care (NG235)*. NICE.

Oladapo, O. T., et al. (2018). WHO model of intrapartum care for a positive childbirth experience. *BJOG*, 125(8), 918–922.

Ravit, M., et al. (2026). Companionship and caesarean sections using Robson classification in LMICs. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 26, 112.

Sandall, J., et al. (2024). Midwife continuity of care for women during pregnancy and childbirthbearing women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2024(1), CD015111.

Bocoum, F. Y., et al. (2023). Barriers and facilitators to implementing companionship during childbirth in Burkina Faso. *Reproductive Health*, 20, 87.

Bohren, M. A., et al. (2023). Provision of continuous companionship during labour: A global scoping review. *PLOS Global Public Health*, 3(1), e0001476.

Hunter, L., et al. (2026). Partners' experiences of childbirth: A systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 26, 447.

Lalonde, A., et al. (2019). The International Childbirth Initiative: 12 steps to safe and respectful MotherBaby–family maternity care. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 146(1), 65–73.

Ministerio de Salud de Chile. (2008). *Manual de atención personalizada en el proceso reproductivo*. MINSAL.

Miranda, J., et al. (2025). FIGO statement on respectful care. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 171, 983–992.

O'Doherty, E., et al. (2025). Care bundles for reducing caesarean section rates. *PLOS ONE*, 20(1), e0295847.

Pace, C. A., Crowther, S., & Lau, A. (2022). Midwife experiences of providing continuity of carer. *Women and Birth*, 35(3), e221–e232.

Rungreangkulkij, S., et al. (2022). Barriers to labor support in Thai hospitals. *Women and Birth*, 35(4), e389–e396.

Shaw, J., et al. (2025). Continuous companionship during labour. *Birth*, 44(4), 295–297.